Wiener Gesundheitsverbund

Für die Stadt Wien

Frau
Eliska PUZIK
Weilandgasse 5A/9
1210 Wien

Wiener Gesundheitsverbund
Klinik Floridsdorf
Kardiologie Station 55 / F5
1210 Wien, Brünnerstraße 68
Tel.: 01-27700/72552
Fax: *Klicken Sie hier, um Text einzugeben.*
E-Mail: kfl.kard@gesundheitsverbund.at
https://klinik-floridsdorf.gesundheitsverbund.at

Entlassungsbrief Pflege

Wien, 12.03.2025/HG
vidiert

Geplantes Entlassungsdatum: 12.03.2025

Entlassungsadresse:
Siehe oben.

Wir berichten über den Aufenthalt von Frau Eliska Puzik, geboren am 18.09.1948, SV-Nr. 2168-180948, welche auf der Kardiologie Station 55 / F5 betreut wurde.
Die individuell erforderliche Pflege und Betreuung ist im beigelegten Pflegeplan in den Entlassungsdokumenten beschrieben.

Pflegediagnosen:

70071	Sturz, Risiko
40152	Ausscheidung, Handhabung beeinträchtigt
40121	Gewebeintegrität, beeinträchtigt, Risiko
50052	Körperliche Mobilität, beeinträchtigt
50122	Selbstpflege Essen/Trinken, beeinträchtigt
50132	Selbstpflege Waschen/Pflegen der äußeren Erscheinung, beeinträchtigt

50182 Selbstorganisation, beeinträchtigt

Mobilität:

Schlüssel	Pflegediagnose	Ausprägung	Ressourcen	Hilfsmittel/Spezifizierung
70071	Sturz, Risiko	Sturzrisiko	Pat. kann sich aktiv Hilfe über die Rufanlage holen Pat. steht nicht alleine auf wenn Unsicherheit besteht. Pat. toleriert notwendige Unterstützung einer PP. Pat. toleriert Antirutschsocken oder festes Schuhwerk Pat. toleriert Bettseitenteile. ist mit Rollator im Zimmer tlw. mobil	

50052	Körperliche Mobilität, beeinträchtigt	Der Patient/Bewohner ist nicht in der Lage sich an der Aktivität zu beteiligen und ist vollständig abhängig, bzw. wie Grad 3 aber unkooperatives Verhalten (vgl. Jones)	Pat. kann sich aktiv Hilfe über die Rufanlage holen Pat. toleriert notwendige Unterstützung einer PP Ist schmerzfrei Hält kurz das Gleichgewicht mit Hilfe einer PP Pat. Kann mit Hilfe 1PP in den Rollstuhl mobilisiert werden.	Rollstuhl

Körperpflege und Kleiden:

Schlüssel	Pflegediagnose	Ausprägung	Ressourcen	Hilfsmittel/Spezifizierung
50132	Selbstpflege Waschen/Pflegen der äußeren Erscheinung, beeinträchtigt	Kann Körperpflege nicht selbständig durchführen, benötigt maximale Unterstützung	Pat. kann sich aktiv Hilfe über die Rufanlage holen Pat. toleriert notwendige Pflegemaßnahmen Pat. toleriert die Mund und Zahnpflege Ist schmerzfrei Äußert Wünsche zum eigenen Erscheinungsbild Wäscht Gesicht, Hände, wenn die benötigten Utensilien in Reichweite sind und wenn PP sie dabei unterstützt/anleitet	

Ernährung:

Schlüssel	Pflegediagnose	Ausprägung	Ressourcen	Hilfsmittel/Spezifizierung
50122	Selbstpflege Essen/Trinken, beeinträchtigt	Kann Mahlzeiten im geringen Umfang selbständig zu sich nehmen benötig überwiegend Unterstüzung (75% und mehr) bei der Vorbereitung und Nahrungsaufnahme	Pat. toleriert notwendige Unterstützung einer PP Pat. toleriert die OK Hochlagerung bei der Nahrungs- und Flüssigkeitseingabe Pat. toleriert die Eingabe der Nahrung und Flüssigkeit durch PP Pat. verfügt über einen Schluckreflex Pat. kann sich aktiv Hilfe über die Rufanlage holen Verwendet geeignete Hilfsmittel (Schnabelbecher)	

Ausscheidung:

Schlüssel	Pflegediagnose	Ausprägung	Ressourcen	Hilfsmittel/Spezifizierung
40152	Ausscheidung, Handhabung beeinträchtigt	Ist vollständig abhängig bei der Ausscheidung, benötigt maximale Unterstützung	Pat. kann sich aktiv Hilfe über die Rufanlage holen Pat. toleriert IKH Versorgung Pat. toleriert notwendige Pflegemaßnahmen kann mit Hilfe von PP und Rollator ad Toilette und retour ins Bett gehen	IKH

Hautzustand:

Schlüssel	Pflegediagnose	Ausprägung	Ressourcen	Hilfsmittel/Spezifizierung
40121	Gewebeintegrität, beeinträchtigt,	Bestehende Haut-, Gewebe- und oder Schleimhaut-schädigung	Pat. toleriert notwendige Pflegemaßnahmen Pat. toleriert Lagerungsmaßnahmen Pat. toleriert Lagerungshilfsmittel Pat. kann sich aktiv Hilfe über die Rufanlage holen ist mit dem Rollator tlw. mobil toleriert ADS	

Die Webseite wurde nicht gefunden.

Weiterführende Informationen (Hautzustand):

Lokalisation	*Wundzustandsbeschreibung*	*Letzter Verbandwechsel lt. ärztl. Anordnung*
Re untere Gesäßhälfte	Dekubitus ca. 7x2cm	12.3.
Li untere Gesäßhälfte	Dekubitus ca. 9x2cm	12.3.

Soziale Umstände und Verhalten:

50182 Selbstorganisation, beeinträchtigt

Weiterführende Informationen (Soziale Umstände):
Pat. Benötigt Unterstützung bei der Haushaltshilfe, Wege, Einkäufe.

Medikamentenverabreichung:

Verabreichung erforderlich
Letzte Medikamentenverabreichung:
☒ Früh

Anmerkungen:
Kostenträger:
Österreichische Gesundheitskasse W

Meldeadresse inkl. Telefonnummer:
1210 Wien, Weilandgasse 5A/9 / Tel.Nr.: 00436505694681

Kontaktperson / Angehörige:
Octavia Tarvpana (Lebensgefährte) Tel.Nr.: 0676/331 56 80
1200 Wien, Stromstraße 39-45/12/4
Jank Christine (Cousin/e) Tel.Nr.: 0699/17110616
Hollabrunn, Raabstraße Nr. nicht bek.
Puikova Karolina (Enkel) Tel.Nr.: 0676 715 70 94
, Adresse nicht bekannt.
Puzile Martin (Sohn) Tel.Nr.: +420 739 922 366
, Der Sohn lebt in Prag.

Entlassungsmanagement:

☒ **Weiterführende Betreuung gesichert durch Andere:**
24h Pflege

☒ **Weiterbetreuung:**

Medizinische Hauskrankenpflege

Erstbesuch am:
14.03.2025

MO-MI-FR für Verbandwechsel.

Wohnungsschlüssel: 24h Pflege zu Hause
Die Kontaktperson / Angehörigen wurden über die Entlassung
☒ verständigt
Enkeltochter

Transport: Krankentransport

Mitgegeben:
☒ Medikamentendispenser
☒ Patientenbrief
☒ Verordnungsschein für Med. HKP

Abschließende Bemerkungen:
Bei Rückfragen: 01-27700/72552

Wir wünschen Ihnen alles Gute,
mit freundlichen Grüßen,
Ihr Gesundheits- und Krankenpflegeteam

vidiert: STLP DGKP Gerhard Gruber

Wiener Gesundheitsverbund
Klinik Floridsdorf

Für die Stadt Wien

Frau
Eliska PUZIK
Weilandgasse 5A/9
1210 Wien

Wiener Gesundheitsverbund
Klinik Floridsdorf
Abteilung für Kardiologie
Vorstand: Priv.Doz.Dr. Georg Delle Karth
1210 Wien, Brünnerstraße 68
Tel.: +43/01/27700/2108
E-Mail: kfl.kard@gesundheitsverbund.at
https://klinik-floridsdorf.gesundheitsverbund.at

Patientenbrief

Wien, 12.03.2025
vidiert

Wir berichten über den stationären Aufenthalt von Frau **Eliska Puzik**, geb. am **18.09.1948, SV-Nr. 2168-180948,** die vom 22.01.2025 bis 12.03.2025 an unserer Abteilung stationär war.

Aufnahmegrund:
Die Vorstellung erfolgte aufgrund von Verschlechterung des Allgemeinzustands und Infekt unklarer Genese.

Diagnosen bei Entlassung:

	Datum von	Datum bis	Status
N17.9, Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet			Aktiv
I48.2, Vorhofflimmern, chronisch			Aktiv
E11.9, Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen			Aktiv
I10, Essentielle (primäre) Hypertonie			Aktiv
I25.9, Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet			Aktiv
G40.6, Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)			Aktiv

Durchgeführte Maßnahmen:
Labor, EKG, C/P, cCT, PM-Abfrage, ECHO, Wunde-Abstrich, Harnstix, MMSE

Empfohlene Medikation:

	Dosierung	Zusatzinformation
LIXIANA FTBL 30MG	*täglich, 1-0-0-0*	
CONCOR COR FTBL 5MG	täglich, 1-0-1-0	
DIOVAN FTBL 160MG	täglich, 1/2-0-0-0	
LAMOTRIGIN 1A TBL LSL 50MG	täglich, 2-0-1-0	
AMLODIPIN +PH TBL 5MG	täglich, 0-0-2-0	
LEVEBON FTBL 1000MG	täglich, 1-0-1,5-0	
EUTHYROX TBL 100MCG	täglich, 1-0-0-0, Di, Mi,	Di, Mi, Fr, Sa
EUTHYROX TBL 150MCG	täglich, 1-0-0-0	Mo, Do
EZEATO TBL 10/20MG	täglich, 0-0-1/2-0	
FORXIGA FTBL 10MG	täglich, 1-0-0-0	
SEDACORON TBL 200MG	täglich, 1-0-0-0	
DULOXETIN +PH MSR HKPS 60MG	täglich, 1-0-0-0	

Unser Therapievorschlag dient als Grundlage für Ihre Weiterbehandlung. Es liegt im Ermessen des weiterbehandelnden Arztes, wirkstoffgleiche Arzneimittel (z.B.Generica) zu verschreiben.

Weitere empfohlene Maßnahmen:
Vorstellung und Weiterbehandlung im niedergelassenen Bereich.

Zusammenfassung des Aufenthalts:
Frau Puzik wurde am 22.02.2025 aufgrund von AZ-Verschlechterung und Infekt unklarer Genese. Laborchemisch zeigte sich erhöhte Entzündungsparameter. Radiologisch zeigte sich das gluteale Fettgewebe beidseits, medialseitig deutlich streifig- entzündlich infiltriert mit diffusen lamellären Flüssigkeitseinlagerungen, deshalb wurde eine antibiotische Therapie etabliert. Ein vorbestehender Dekubitus wurde chirurgisch begutachtet und weiterbehandelt. Im Verlauf des Aufenthalt nahmen die Entzündungsparameter unter Antibiotikatherapie drastisch ab und die Patientin kann in gutem Allgemeinzustand nach Hause entlassen werden.

Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken:
Keine Medikamentenallergien bekannt

Auszüge aus erhobenen Befunden:
Nach Aufnahme erhobene Befunde im Anhang

- EKG vom Aufnahmetag (Klinik Floridsdorf): Vorhofflimmern, 107/min, Linkstyp, ST-Strecken isoelektrisch
- Labor vom 22.01.2025: Krea: 2,2, Kalium: 4,3, PTZ: 72 %, TSH: 0,50, CK: 7777
- NT-pro-BNP: 2152

Anamnese:
Aktuelle Anamnese/Beschwerden: Dyspnoe und Schwäche
Vegetative Anamnese: Stuhl- und Harnanamnese o.B.
Sozialanamnese: Wohnt alleine
Drogen / Alkohol: Negiert / Negiert
Nikotin: Negiert Ex seit: TT.MM.JJJJ
Zig./d: Stück Pack Years: 25
Familienanamnese: Negativ
Mobilität/Selbständigkeit:

diktiert: KPJ Oksana Kotsiubynska

Mit freundlichen Grüßen
Der Abteilungsvorstand

vidiert: Oberarzt Dr. Markus Riegersperger

Priv.Doz.Dr. Georg Delle Karth

Erhobene Befunde:

Version: 1

Klinik Floridsdorf

Name: Puzik, Eliska
Pat.-Nr.: 509858
Geb.: 18.09.1948

Indikation: LVF?

Größe: 168 cm
Gewicht: 100 kg
Geschlecht: Weiblich
KOF: 2,09 m²
HF: 60 bpm

Abteilung für Kardiologie
Brünnerstraße 68, 1210 Wien
Tel.Nr.: + 43 1 27700 2108
Fax: + 43 1 27700 99 2108
afl.kard@gesundheitsverbund.at

Transthorakale Echokardiographie

Unters.-Datum: 03.02.2025, 13:29

Zur Untersuchung: Mittelmäßige transthorakale Untersuchungsqualität. Bedside-Echo. Es liegt ein normofrequenter Sinusrhythmus vor.

Linker Ventrikel: Kleinlumiger linker Ventrikel. Gering- bis mittelgradige Hypertrophie. Hypertrophie überwiegend des Septums. Die globale systolische Funktion ist grenzwertig normal. Bei mäßiger Schallqualität keine eindeutige regionale Wandbewegungsstörung.

Diastolische Funktion: Diastolische Dysfunktion Grad I.

Linker Vorhof: Der linke Vorhof ist normal groß.

Rechter Ventrikel: Der rechte Ventrikel ist normal groß. Die Rechtsventrikelfunktion ist normal.

Rechter Vorhof: Der rechte Vorhof ist normal groß.

Aortenklappe: Die Aortenklappe ist trikuspid. Gering verdickt. Keine Aortenklappenstenose. Keine Aortenklappeninsuffizienz.

Mitralklappe: Die Mitralklappe ist gering verdickt (nicht rheumatisch). Geringe Mitralringverkalkung. Geringgradige Mitralinsuffizienz.

Trikuspidalklappe: Die Trikuspidalklappe ist morphologisch unauffällig. Geringgradige Trikuspidalklappeninsuffizienz. Kein Hinweis auf pulmonale Hypertonie. Mit Vorbehalt bei schwachem CW Signal.

Aorta: Aorta ascendens im eingesehenen Bereich normal dimensioniert.

Perikard: Kein Perikarderguss.

VCI: Die Vena cava inferior ist normal weit. Die Vena cava inferior mit erhaltener respiratorischer Kaliberschwankung.

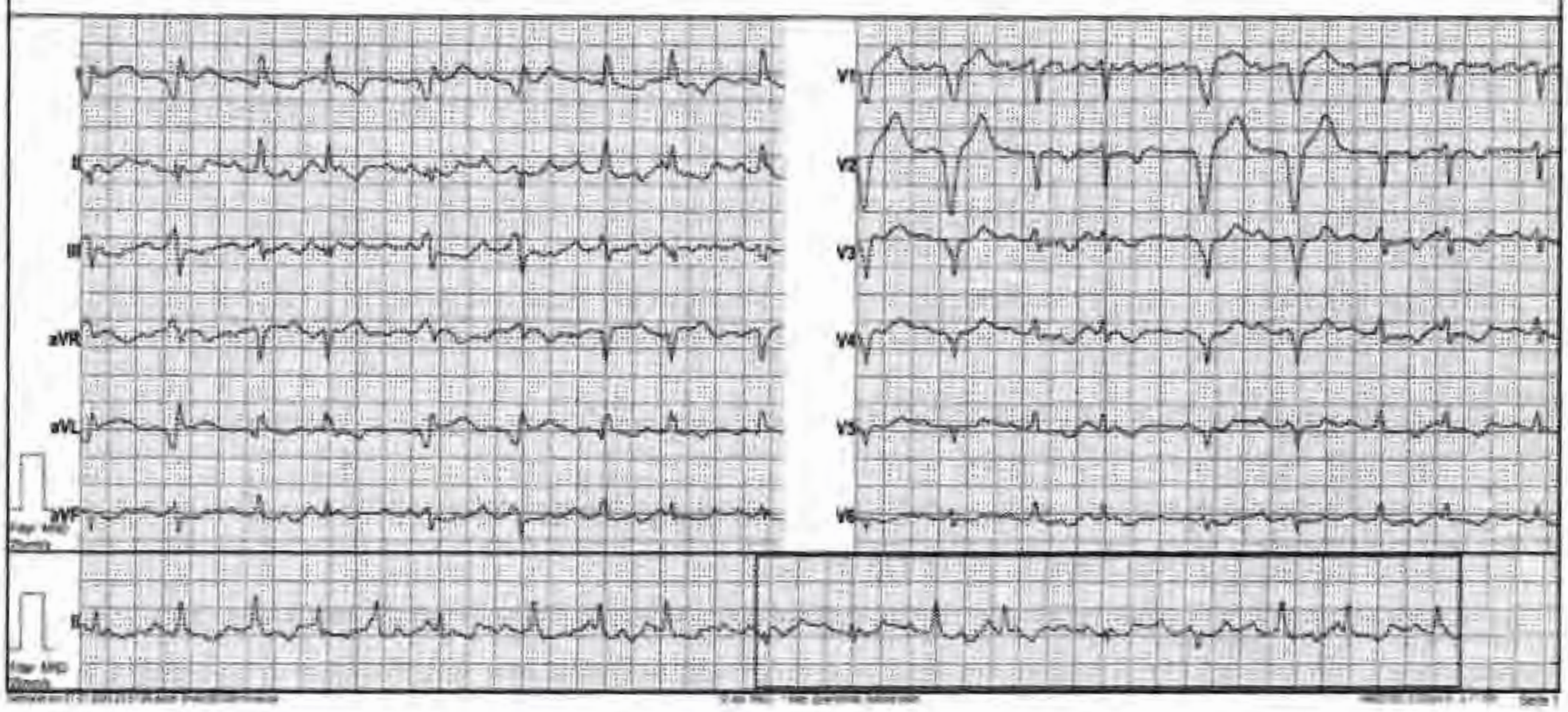
Linker Ventrikel	**Aorta**	**Aortenklappe**	**Diastole / Mitralklappe**	**Trikuspidal-/Pulmonalklappe**
LVIDd: **35 mm**	Ao asc D: **28 mm**	AV Vmx: **1,7 m/s**	MV E Vmx: **49 cm/s**	TR Vmx: **2,2 m/s**
IVSd: **13 mm**	**Linker Vorhof**	AV MPG: **4,4 mmHg**	MV A Vmx: **84 cm/s**	sPAP: **24,9 mmHg**
LVPWd: **9 mm**	LAVI(MOD-sp4): **32 ml/m²**	AV mx PG: **11,5 mmHg**	MV E/A: **0,58**	RAP syst.: **5 mmHg**
Rechter Ventrikel	**Rechter Vorhof**	LVOT Vmx: **1,14 m/s**	Med E' Vmx: **5 cm/s**	
RVd Basis: **27 mm**	RAVI(MOD-sp4): **13 ml/m²**	LVOT MPG: **2,40 mmHg**	E/e' Med: **10**	
TDI S': **12,1 cm/s**		LVOT mx PG: **5,2 mmHg**		

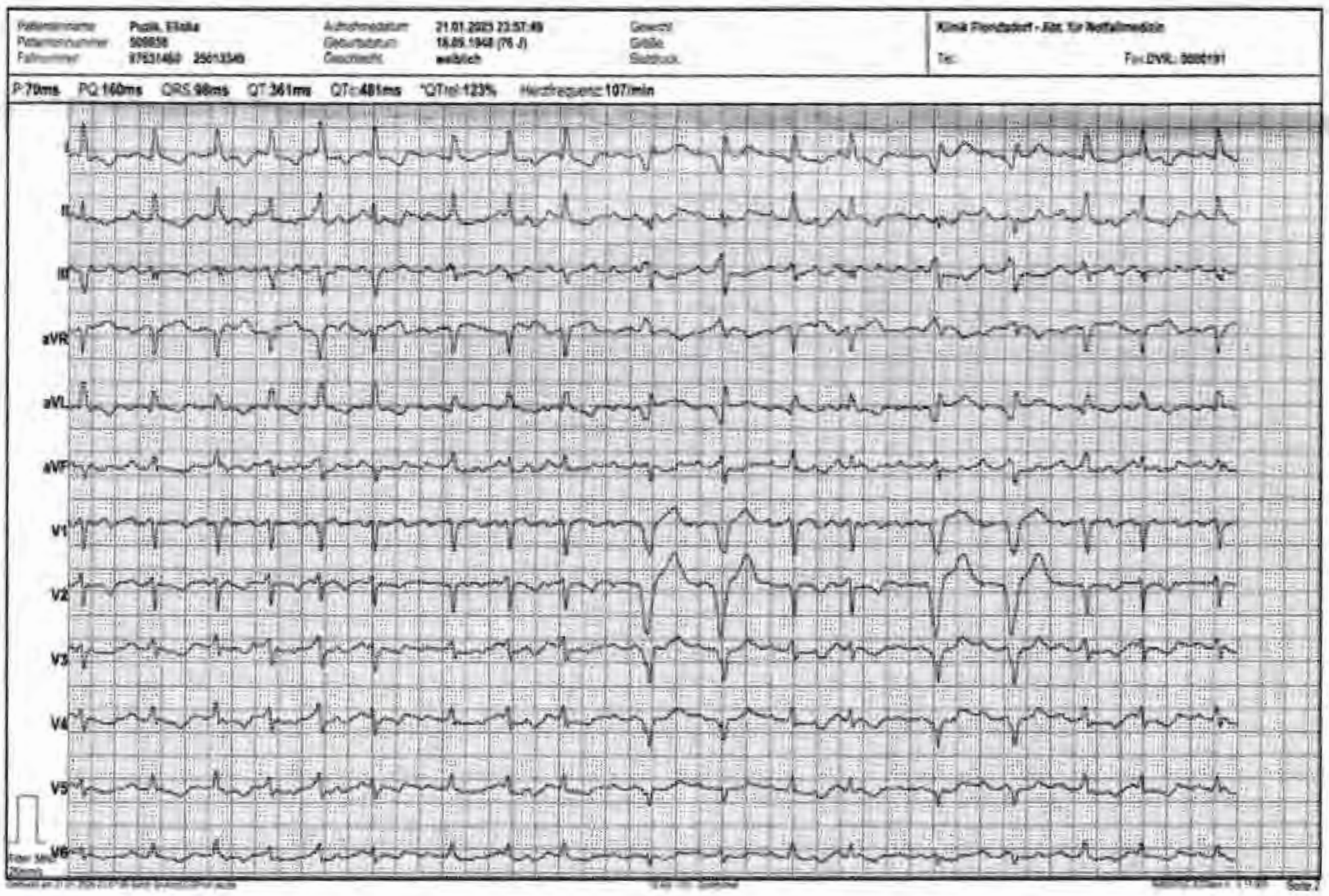
Untersucht von: Armita Rakwan Vidiert von: OA Dr. Chao Zhang 04.02.2025, 08:14

EACVI European Association of Cardiovascular Imaging **Europäisch zertifiziertes Echolabor**

Page 1 of 1

04.02.2025





CT

Becken knöchern, CT Sacrum, ISG vom 24.01.2025 10:12:00

Das gluteale Fettgewebe ist beidseits medialseitig deutlich streifig- entzündlich infiltriert mit diffusen lamellären Flüssigkeitseinlagerungen.

Eine umschriebene, liquide, retentionssuspekte Flüssigkeitskollektion ist derzeit nicht differenzierbar. Kein Nachweis eines pathologischen KM-Enhancements. Eine osteolytischen Osteodestruktion ist nicht erkennbar. Deutliche bilaterale Koxarthrose. >> Bei protrahierten Klinik ergänzende sonographische Korrelation.

US Haut, Muskulatur, Weichteile vom 22.01.2025 12:29:00
Entzündlich verändertes subkutanes Fettgewebe beidseits gluteal (rechts > links), DD Pannikulitis DD Phlegmone.
Sonographisch kein Nachweis einer abszessverdächtigen Retention.
CT Schädel vom 22.01.2025 03:26:00
Zusammenschau mit externer cMRT vom 06.07.23. Kein Nachweis einer intrakraniellen Hämorrhagie oder rezenten Fraktur der Schädelkalotte. Bekannt ausgedehntes Keilbeinmeningeom links mit angrenzendem Parenchymdefekt im linken Frontallappen.
Thorax vom 22.01.2025 00:46:00
Bildvergleich mit der Letztuntersuchung vom 02.08.2024. Cor im grenzwertig oberen Normbereich ohne signifikante Stauungszeichen. Keine Pleuraergüsse. Keine entzündlichen Veränderungen.
Herzschrittmacheraggregat links pektoral mit zwei konnektierten Sonden.

Mikrobiologie vom 04.02.2025
E-Nr. 005321/2025
Material: Mittelstrahlharn
Entnahmetechnik: Harn

Befund:
Candida albicans 10**6

Urethrale Mischflora 10**3

Mikrobiologie vom 27.01.2025
E-Nr. 004127/2025
Material: Wunde
Entnahmetechnik: Abstrich

Befund:
Candida albicans 10**+

Enterococcus faecalis 10**++

S	Amoxicillin+Clavulansäure
S	Ampicillin
S	Ampicillin/Sulbactam
S	Vancomycin
S	Tigecyclin

Enterococcus faecium 10**++

R	Amoxicillin+Clavulansäure
R	Ampicillin
R	Ampicillin/Sulbactam
S	Vancomycin
S	Linezolid
S	Tigecyclin

Bakterien der normalen Hautflora 10**++

Mikrobiologie vom 22.01.2025
E-Nr. 003295/2025
Material: Blutkultur Set (aerob/anaerob)
Entnahmetechnik: Blutabnahme

Befund:
KEIN WACHSTUM
E-Nr. 003296/2025
Material: Blutkultur Set (aerob/anaerob)
Entnahmetechnik: Blutabnahme

Befund:
KEIN WACHSTUM

Mikrobiologie vom 22.01.2025
E-Nr. 003293/2025
Material: Blutkultur Set (aerob/anaerob)
Entnahmetechnik: Blutabnahme

Befund:

KEIN WACHSTUM

E-Nr. 003294/2025
Material: Blutkultur Set (aerob/anaerob)
Entnahmetechnik: Blutabnahme

Befund:
KEIN WACHSTUM

Mikrobiologie vom 22.01.2025
E-Nr. 003291/2025
Material: Blutkultur Set (aerob/anaerob)
Entnahmetechnik: Blutabnahme

Befund:
KEIN WACHSTUM

E-Nr. 003292/2025
Material: Blutkultur Set (aerob/anaerob)
Entnahmetechnik: Blutabnahme

Befund:
KEIN WACHSTUM

Konsiliarbefund vom 12.02.2025 **KLINIK FLORIDSDORF**	
Phys. Med. u. Rehabilitation Inst. f. Physikalische Medizin u. Rehabilitation 1210 Wien, Brünnerstraße 68 Tel. +43/01/27700/3408 Prim. Univ.Prof.Dr. Tatjana Paternostro-Sluga	**Patientenbrief** 12.03.2025/frt2001 vidiert
Patient: **Eliska Puzik (W)** Gebdat.: 18.09.1948 Pat.AZ: 97639998/25/013380	

Zugewiesen von: Kardiologie Station 55 / F5

Datum der Begutachtung: 12.02.2025

Fragestellung lt. Zuweisung:
erbitte beg. zur Remob

Diagnose lt. Zuweisung:
st.p. Sturz

Zusatzvermerk lt. Zuweisung:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Konsilerbringende Stelle: Inst. f. Physikalische Medizin u. Rehabilitation

Antwort:
Pat kommt zur Begutachtung auf die AGR.
Stationäre Aufnahme bei Rhabdomyolyse bei Liegetrauma, Vd.a.Pneumonie, Tachy VHF.
MMSE 23/30

SA: lebt alleine, keine Stufen, 1 Enkelin

Kooperativ, Eupnoe OE altersentsprechend frei, FS komplett
Pat schafft den Transfer vom Sitzen in den Stand mit RM

Neurologische Abklärung empfohlen: Mb Parkinson?
Pat nicht für AGR geeignet da die Versorgung nach E nicht geklärt ist.
EM EINBEZIEHEN! PH? Pat kann sich derzeit anamn, nicht vorstellen mit HH nach Hause entlassen zu werden. Sobald die Versorgung nach E geklärt ist kann eine erneute Begutachtung erfolgen.

diktiert: Assistenzärztin Dr.in Theresa Zehetbauer

vidiert: Oberarzt Dr. Markus Riegersperger

Konsiliarbefund CHI vom 22.01.2025

Zugewiesen von: Notfallmedizin Station 13/C1

Datum der Begutachtung: 22.01.2025

Fragestellung:
Wie telefonisch besprochen Pat. mit Rhabdomyolyse bei Liegetrauma, aktuell beginnend septisch bei massivem glutealen Abszess mit Nekrosen sowie Spannungsblasen li>re
Relevante Diagnosen:
Tachykardes VHF
Akute Niereninsuffizienz auf CKD
Zusatzvermerk:
Pat. aufgrund vom red. AZ in die ZNA vorstellig geworden; bei der Begutachtung chron. Wunden im Glutealbereich bds festgestellt; anamnestisch besteht eine Rhabdomyolyse und dementsprechender laborchemischer Befund

Klin. Begutachtung: chron. Wunden im Glutealbereich, oberflächliche Haut netkrotisch und in Demarkierung; beim tasten lässt sich keine Abszessverdächtige Formation in der subcutis bzw. in der Tiefe feststellen; es tritt auch kein Eiter aus der Wunde; diese auch nicht derb oder schmerzhaft

US (lt tel. Übergabe): ödematöse Weichteilgewebe, kein Hinweis auf Abszess

Empfehlung: stat. Aufnahme auf der Internen und konservative Therapie; weiters tgl. Wundmanagement; chir. Konsil zur Begutachtung kann im Verlauf gerne gestellt werden

Konsiliarbefund vom 30.01.2025

Zugewiesen von: Kardiologie Station 55 / F5

Datum der Begutachtung: 30.01.2025

Fragestellung:
LA! Pat mit Liegetrauma aufgenommen, initial sehr red AZ nun dtl Besserung. in den Voriagnosen Grand Mal beschrieben- Therapie mit nur Lamotrigen 25mg. Theapie Optimierung? Vielen Dank
Relevante Diagnosen:
Frühere Erkrankungen:
KHK
St.p. Schrittmacherimplantation DDD-R am 26.02.2018 (St. Pölten) bei Tachy-Brady-Syndrom und paroxysmalem Vorhofflimmern
St.p. Koronarangiographie am 11.05.2021:
Wandunregelmäßigkeiten in allen Koronarien
Ca. 30 - 40 %ige Stenose im Bereich der LAD am Übergang vom mittleren zum distalen Drittel, wo das Gefäß schon sehr klein ist
Paroxysmales Vorhofflimmern (OAK)
St.p. frustrane ECV 03/2021
Arterielle Hypertonie
Diabetes mellitus Typ 2 (HbA1C 6,7%)
Chronische Niereninsuffizienz
Hyperlipidämie
Keilbeinmeningeom links mit perifokalem Ödem
Grand-Mal-Epilepsie

St.p. Thyreoidektomie und Nebenschilddrüsen Exstirpation am 12.09.2017
St.p. Schwanzpankreatitis
St.p. Basaliomexstirpation 2015
Zusatzvermerk:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben

Nach Durchsicht der Webokra-Befunde ist es schon oft zu synkopalen Ereignissen/Bewusstlosigkeiten gekommen, deren Ätiologie immer entweder epileptischen Anfällen oder ihrem Sick-Sinus-Syndrom zugeordnet wurden.
Sichere Infos über epileptische Anfälle haben wir nicht, doch es kann selbstverständlich sein, dass Anfälle auftreten immerhin liegt eine große RF in einer potenziell Anfallsversursachenden Region vor. Die Patientin wollte sich bisher noch nicht operieren lassen, das Keilbeinmeningeom hat aber ordentliche Ausmaße angenommen und eine OP wäre prinzipiell indiziert.

Ich würde nun pragmatisch empfehlen, Lamotrogin aufzudosieren in einen wirksamen Dosisbereich, um mögliche Anfälle zu verhindern. Bitte jetzt auf 2x 25mg steigern (alle 12h geben), dann in 3 Tagen auf 2x 50mg steigern und nach weiteren 7 Tagen auf 100-0-0-50mg steigern. Eine Woche danach bitte nüchtern Lamotriginspiegel abnehmen (Versand ans AKH).

Bitte auch ein EEG zuweisen.

Konsiliarbefund vom 07.02.2025

Zugewiesen von: Kardiologie Station 55 / F5

Datum der Begutachtung: 07.02.2025

Fragestellung:
LA! Pat bei Z.n. Liegentrauma aufgenommen, hierorts sehr antriebslos, macht nicht viel obowohl sie es schaffen könnte, leicht reizbar- FÄB h.e. Depression?
Relevante Diagnosen:
Epilepse
Keilbeinmeningeom
Zusatzvermerk:
Akutbegutachtung 07.02.2025, 16:10

Patientin im Bett angetroffen, im Kontakt freundlich, zugewandt. Sie kann ihren Namen, Geburtsdatum, Alter, Adresse und Aufenthaltsort korrekt nennen. Aktuelles Datum kann nur mit Februar 2025 angeführt werden. Sie beschreibt als Grund ihrer Klinikaufnahme zu Hause einen epileptischen Anfall gehabt zu haben, ein Bekannter habe sie nicht erreichen können, der dann ihren Sohn verständigt habe und sie wurde schließlich in die Klinik gebracht. Ohnmachtszustände würden sich öfters ereignen. Bezugnehmend an Vorerkrankungen schildert sie eine Epilepsie, berichtet von einem Herzschrittmacher. Weitere Vorerkrankungen kann sie nicht nennen. Welche Medikamente sie im Detail nehme wisse sie nicht, diese würden ihr vorbereitet werden.

Seit 10 Jahren leide Frau P. unter rezidivierenden Depressionen, sei bis vor einem Jahr über die Dauer von 3-4 Jahren in psychologischer Behandlung gestanden. Angesprochen auf eine psychopharmakologische Therapie kann sie keine Angaben tätigen. Während der Exploration beklagt Frau P. wiederholt Gedächtnislücken, sie könne sich an Verschiedenes nicht mehr erinnern.

Aktenanamnestisch ist eine Multimorbidität erhebbar.

Anamnestisch keine Allergie. Alkoholabusus negiert. Anamnestisch keine Suizidversuche, kein selbstverletzendes Verhalten.

Aus der SA: Wohne seit 1968 in Österreich. Sei von Beruf Buchhalterin gewesen, seit dem 60.Lj. pensioniert. Ein Sohn 53a alt, der in Prag leben würde. Ihr Ehegatte habe sie vor 25 Jahren verlassen, er wohne ebenfalls in Prag; sie sei geschieden.
Frau P. schildert den Alltag alleine zu bewältigen sie wäre mit Rollator unterwegs.

Aus dem PPS: Bewusstseinsklar, Im Wesentlichen orientiert. Kognitiv-mnestisches Leistungsspektrum auffallend reduziert, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Zeitgitterstörungen. Optische oder akustische Halluzinationen werden negiert, derzeit keine Expansivität oder Produktivität explorierbar, Stimmung depressiv, Anhedonie, allgemeines Losigkeitssyndrom. Affizierbarkeit primär im negativen Skalenbereich. Psychomotorisch ruhig. Schlaf medikamentös gestützt. Derzeit keine Gefährdung im Sinne des UbG.

Psy.Dg:
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode F33.1
Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit / Hirnorganisches Psychosyndrom bei Keilbeinmeningeom F06.9

Psy.Med.empfehlung:
Duloxetin 60mg Kps. 1-0-0-0

CAVE: Etablierte Sedacoron-Therapie.

Außenanamnese erbeten.
Psychologische Testung, Abklärung Psychoorganizität/Demenzdiagnostik. Bitte um MMSE-Test.

CCT (Sturzgeschehen im Vorfeld der Aufnahme?) sowie cMRT wenn keine Kontraindikation.
EEG-Untersuchung.

Regelmäßige Labor,- EKG(QTc),- Blutdruck- und Pulskontrollen unter Psychopharmakotherapie.
Luesserologie, Parathormon, Kontrolle der Elektrolyte, Schilddrüsenfunktionsparameter!

Psychologische Betreuung.

Neurologische bzw. neurochirurgische Weiterbetreuung (Keilbeinmeningeom).

In der Folge Vorstellung in einer Gedächtnisambulanz:
AKH Wien, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Gedächtnisambulanz
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Kliniken am Südgarten
Telefon: +43 (0) 1 40 400 - 35470
oder
Klinik Hietzing, Gedächtnisambulanz der Neurologischen Abteilung
Wolkersbergenstraße 1, Pavillon 8 - 1. Stock, 1130 Wien
Telefon: +43 (0) 1 80 110 3433

Kontrolle bei Bedarf.

Mit freundlichen Grüßen und besten Dank

Labor: Klinik Floridsdorf, Kumulativbefund: Kumulativbefund (global), alle Aufenthalte
PUZIK Eliska, geb.:18.09.1948 W, #2168

Hinweis: Es werden nur Befunde vom 21.01.2025 bis 14.02.2025 angezeigt.

Hinweis: Sämtliche Kumulativbefunde wurden im Zuge von ELGA auf LOINC umgestellt. Ältere Laborbefunde sind nur mehr als Einzelbefund einsehbar.

		21.01.25 23:53	22.01.25 02:05
Blutgasanalytik			
pH arteriell	7.37 - 7.45 -		7.39
pCO2 arteriell	35 - 46 mm Hg		* 26.6
pO2 arteriell	70 - 100 mm Hg		* 64.4
FO2-Hb arteriell	94 - 98 %		* 89.0
O2 Gehalt art.	18 - 23 mL/dL		21.1
O2-Sättigung art.	95 - 99 %		* 90
Base excess art.	-2 - 3 mmol/L		* -6.3
Bikarbonat arteriell	21 - 26 mmol/L		* 16.17
Laktat art.	- 1.8 mmol/L		* 2.3
Natrium art.	135 - 145 mmol/L		140
Kalium art.	3.6 - 4.8 mmol/L		3.8
Calcium ion. art.	1.12 - 1.32 mmol/L		1.24
Chlorid art.	95 - 105 mmol/L		104
Anionenlücke 4P art.	7 - 16 mmol/L		* 23.0
Glucose art.	70 - 100 mg/dL		* 191

Kreatinin art.	0.6 - 1.1 mg/dL		* 1.9
Hct art.	38 - 44 %		* 51
Hämoglobin art.	12.5 - 16 g/dL		* 16.8
Deoxy.Hämoglob. art.	- 5 %		* 10.4
Carboxyhämoglob. art	- 2 %		0.4
Methämoglobin art.	- 1.5 %		0.3
pH venös	7.31 - 7.41 -	7.32	
pCO2 venös	41 - 51 mm Hg	* 34.0	
pO2 venös	35 - 40 mm Hg	* 33.2	
FO2-Hb venös	70 - 80 %	* 39.5	
tO2 venös	- mL/dL	9.9	
O2-Sättigung venös	55 - 70 %	* 40	
Base excess venös	-2 - 3 mmol/L	* -6.6	
Bikarbonat venös	21 - 26 mmol/L	* 17.77	
Laktat ven.	0.5 - 2.2 mmol/L	* 5.1	
Natrium ven.	135 - 145 mmol/L	139	
Kalium ven.	3.6 - 4.8 mmol/L	4.7	
Calcium ion. ven.	1.12 - 1.32 mmol/L	1.23	
Chlorid ven.	95 - 105 mmol/L	103	
Anionenlücke 4P ven.	7 - 16 mmol/L	* 23.2	
Glucose ven.	70 - 100 mg/dL	* 190	
Kreatinin ven.	0.6 - 1.1 mg/dL	* 2.3	
Hct ven.	38 - 44 %	* 53	
Hämoglobin venös	12.5 - 16 g/dL	* 17.6	
Deoxy.Hämoglob. ven	- 5 %	* 40.0	
CO-Hämoglobin ven.	- 2 %	0.5	
Methämoglobin ven	- 1.5 %	0.5	
Beatmungswert (FIO2)	- %	20.9	20.9

		21.01.25 23:57	23.01.25 10:20	25.01.25 08:47	28.01.25 09:51	30.01.25 09:38	03.02.25 09:44	11.02.25 09:28
HÃ¤matologie								
Leukozyten	4.0 - 10.0 G./L	* 12.2	7.9	5.5	7.4	6.1	5.1	5.5
Thrombozyten	160 - 360 G./L	183	* 148	* 148	235	272	240	257
Erythrozyten	3.8 - 5.2 T/L	* 6.0	4.9	4.4	5.1	4.8	4.8	4.7
Hämoglobin	11.8 - 15.8 g/dL	* 17.4	14.2	12.8	14.6	14.1	13.7	13.5
Hämatokrit	35.0 - 45.5 %	* 52.3	42.7	39.0	44.5	42.2	42.3	41.6
MCV	80 - 101 fL	87	87	88	88	87	89	88
MCH	27.0 - 34.0 pg	29.0	29.0	29.0	28.7	29.1	28.7	28.5
MCHC	31.5 - 36.0 g/dL	33.3	33.3	32.8	32.8	33.4	32.4	32.5
RDW-CV	11.5 - 15.0 %	14.9	14.6	14.5	13.6	13.8	14.4	14.1
Neutroph. Gran. abs.	1.5 - 7.7 G./L	* 10.5	6.6	4.0	5.5		3.3	3.7
Lymphozyten abs.	1.1 - 4.0 G./L	* 0.6	* 0.6	* 0.8	1.2		1.1	1.2
Monozyten abs.	0.1 - 0.9 G./L	* 1.1	0.7	0.5	0.4		0.6	0.4
Eosinophile Gr. abs.	0.1 - 0.5 G./L	* 0.0	* 0.0	* 0.1	0.2		* 0.0	* 0.1
Basophile Gr.abs.	0.0 - 0.2 G./L	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0
Neutroph. Gran. rel.	42.0 - 77.0 %	* 86.2	* 83.6	73.5	74.6		64.8	67.7
Lymphozyten rel.	20.0 - 44.0 %	*** 4.6	*** 8.0	* 15.1	* 15.9		22.0	22.3
Monozyten rel.	2.0 - 9.5 %	9.0	8.3	9.4	5.5		* 11.8	8.0
Eosinophile Gr. rel.	0.5 - 5.5 %	* 0.0	* 0.0	1.6	3.2		1.0	1.5
Basophile Gr.rel.	0.0 - 1.8 %	0.2	0.1	0.4	0.8		0.4	0.5
Segmentkern. abs.mi.	1.7 - 7.2 G./L					4.4		
Stabkernige abs. mi.	- 1.1 G./L					0.1		
Metamyeloz. abs. mi.	- G./L					* 0.1		
Lymphozyten abs. mi.	1.1 - 4.0 G./L					* 1.0		
Monozyten abs. mi.	0.1 - 0.9 G./L					0.4		
Eosinoph.Gr.abs. mi.	0.1 - 0.5 G./L					0.1		
Basophile Gr.abs.mi.	0.0 - 0.2 G./L					0.1		
Segmentkern. rel.mi.	40.0 - 70.0 %					* 71.2		
Stabkernige rel. mi.	- 10.0 %					0.9		
Metamyeloz. rel. mi.	0.0 - 0.0 %					* 0.9		
Lymphozyten rel. mi.	20.0 - 44.0 %					* 17.1		
Monozyten rel. mi.	2.0 - 9.5 %					7.2		
Eosinoph.Gr.rel. mi.	0.5 - 5.5 %					1.8		
Basophile Gr.rel.mi.	- 1.8 %					0.9		
Normobl.(NRBC)ab.mi.	- 0.0 G./L					* 0.1		

Normobl.(NRBC)Rt.mi.	- 0.0 /100 Leuko					* 0.9		

		21.01.25 23:57
Gerinnung/HÃ¤mostaseologie		
PTZ (Prothrombinz.)	70.0 - 130.0 %	72
INR	0.85 - 1.2 -	1.19
aPTT	21 - 32 sek	31
Fibrinogen	1.8 - 4.0 g/L	*** 8.1

Kommentare zu Analyten:

21.01.25 23:57	**INR**	INR nur gültig bei oraler Antikoagulation. |Therapeutischer Bereich: 2.0 - 4.6
	aPTT	Achtung! Änderung des Referenzbereichs.

		21.01.25 23:53	21.01.25 23:57	22.01.25 02:05	22.01.25 05:57	23.01.25 10:20	25.01.25 08:47	28.01.25 09:51
Klinische Chemie/Proteindiagnostik								
CRP	- 5.0 mg/L		* 203.63			*** 314.22	* 169.63	* 51.62
Natrium	136 - 145 mmol/L		139			140	140	* 135
Kalium	3.4 - 4.5 mmol/L		4.3			4.3	3.7	HAEMOLYSE
Chlorid	98 - 107 mmol/L		101			104	104	102
Calcium	2.2 - 2.6 mmol/L					* 2.2	* 2.0	* 2.1
Phosphat	0.81 - 1.45 mmol/L		1.31					
Magnesium	0.66 - 0.99 mmol/L		0.98					
Mg ionisiert /B	0.46 - 0.6 mmol/L	* 0.82		* 0.64				
Kreatinin	0.5 - 0.9 mg/dL		* 2.2			* 1.4	0.8	* 1.0
GFR/1.7m2KO (CKDEPI)	60 - 500 mL/min/1.7m2		*** 21			* 37	68	* 55
BUN	8 - 23 mg/dL		* 51			* 43	22	12
Harnsäure	2.4 - 5.7 mg/dL		* 6.4					
CK	- 167 U/L		*** 7777			*** 2598	* 782	HAEMOLYSE
CK-MB	- 24 U/L		*** 169			HAEMOLYSE	16	
NT-pro-BNP	- 125 ng/L		* 2151			* 363	* 538	* 306
ASAT (GOT)	- 35 U/L		* 169			* 117	* 91	HAEMOLYSE
ALAT (GPT)	- 35 U/L		* 56			* 64	* 92	* 74
Gamma-GT	- 40 U/L		25			15	19	26
Alk.Phosphatase (AP)	35 - 104 U/L		103					
Cholinesterase	5320 - 12920 U/L		9039					
Bilirubin	- 0.9 mg/dL		* 1.0					
Lipase	13 - 60 U/L		17					
LDH	- 250 U/L		* 580					
Eisen	33 - 193 µg/dL					* 19		
Transferrin	2.00 - 3.60 g/L					* 1.37		
Transferrinsättigung	16.0 - 45.0 %					* 9.7		
Ferritin	15 - 150 µg/L					* 459		
Glucose	60 - 100 mg/dL		* 170			* 178		
Hämoglobin A1c	4.0 - 6.0 %					* 6.5		
Hämoglobin A1c IFCC	20.2 - 42.1 mmol/mol					* 47.0		
Cholesterin	- 200 mg/dL		195			144		
HDL-Cholesterin	65 - mg/dL					66		
LDL-Cholesterin	- 130 mg/dL					59		
Triglyceride	- 150 mg/dL		106			83		
Lipoprotein (a)	- 75 nmol/L					* 98		
Glucose (POC)(05:30)	65 - 95 mg/dL				* 164			
Albumin	35.0 - 52.0 g/L		42					

Kommentare zu Analyten:

21.01.25 23:57	**LDH**	Probe leicht hämolytisch, Kontrolleinsendung empfohlen
23.01.25 10:20	**Kalium**	ACHTUNG! Hämolyse stört! Hämolyse Index beachten!
	ASAT (GOT)	Probe leicht hämolytisch, Kontrolleinsendung empfohlen

		30.01.25 09:38	03.02.25 09:44	11.02.25 09:28
Klinische Chemie/Proteindiagnostik				
CRP	- 5.0 mg/L	* 44.27	* 44.41	* 10.23
Natrium	136 - 145 mmol/L	140	* 133	138

Kalium	3.4 - 4.5 mmol/L	4.0	HAEMOLYSE	3.8
Chlorid	98 - 107 mmol/L	105	101	103
Calcium	2.2 - 2.6 mmol/L	2.2	* 2.0	2.3
Kreatinin	0.5 - 0.9 mg/dL	* 1.1	* 1.3	* 1.2
GFR/1.7m2KO (CKDEPI)	60 - 500 mL/min/1.7m2	* 48	* 38	* 43
BUN	8 - 23 mg/dL	* 8	16	14
CK	- 167 U/L	153	HAEMOLYSE	53
NT-pro-BNP	- 125 ng/L	* 305	52.0	* 1865
ASAT (GOT)	- 35 U/L	35		21
ASAT (GOT)	13 - 40 U/L		HAEMOLYSE	
ALAT (GPT)	- 35 U/L	* 59		20
ALAT (GPT)	- 40 U/L		HAEMOLYSE	
Gamma-GT	- 40 U/L	27		25
Gamma-GT	- 38 U/L		HAEMOLYSE	

Kommentare zu Analyten:

30.01.25 09:38 **ASAT (GOT)** Probe leicht hämolytisch, Kontrolleinsendung empfohlen

		21.01.25 23:57	23.01.25 10:20
Hormone/Vitamine/Tumormarker			
TSH	0.27 - 4.2 µU/mL	0.50	
Folsäure	4.80 - 37.30 ng/mL		7.80
Vitamin B12	197 - 771 pg/mL		333

		22.01.25 00:43	04.02.25 09:26
Urindiagnostik			
Spez.Gew./U Teststr.	1.01 - 1.025 kg/L	>=1.030	
Spez.Gew./U Teststr.	1.001 - 1.035 kg/L		1.025
pH /U Teststr.	5 - 6 -	5.5	
pH /U Teststr.	4.5 - 8 -		5
Leuko /U Teststr.	- 5 /µL	0	
Leuko /U Teststr.	0 - 25 /µL		25
Nitrit /U ql.Tests.	-	Negativ	negativ
Ery. /U Teststr.	- 5 /µL	Ca 80	250
Tot.Prot./U Teststr.	- mg/L	100	
Tot.Prot./U Teststr.	0 - 50 mg/L		25
Glucose/U Teststr.	- 15 mg/dL	* 500	
Glucose/U Teststr.	0 - 10 mg/dL		* 1000
Keton /U Teststr.	0 - 5 mg/dL	Negativ	negativ
Bilirubin/U Teststr.	- mg/dL	Schwach	
Bilirubin/U Teststr.	0 - 0.2 mg/dL		negativ
Urobilin./U Teststr.	- 1.0 mg/dL	0.2	
Urobilin./U Teststr.	0 - 0.2 mg/dL		negativ

Kommentare zu Analyten:

22.01.25 00:43 **Leuko /U Teststr.** CRSNote1& CRSNote2&

Kommentare zu Gesamtbefunden:

21.01.25 23:57 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 16
23.01.25 10:20 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 63| Index Hämolytisch S1 [S_H_S1_INFO]: 25
25.01.25 08:47 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 3
28.01.25 09:51 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 115
30.01.25 09:38 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 24
03.02.25 09:44 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 584
11.02.25 09:28 Index Hämolytisch PH1 [S_H_PH1_INFO]: 12